

Université de Constantine 3 Faculté de médecine Belkacem Bensmaine CHU de Constantine

Laboratoire d'anatomie humaine

Médecin chef : Pr. Boulacel. A

Polycopié pour les étudiants de la 1ère année médecine

Dr. BOUZIDI Esma

## **L'Articulation De la Hanche (coxofemorale)**

### **PLAN**

#### **I- Introduction**

#### **II- Anatomie Descriptive**

##### **1- Surfaces articulaires**

##### **2- Moyens d'unions**

###### **A- La capsule**

###### **B- Les ligaments passifs**

###### **C- Les ligaments actifs**

##### **3- La synoviale**

#### **III- Anatomie fonctionnelle**

### **Objectifs**

- Savoir classer une articulation
- Connaître les différentes surfaces articulaires qui forment une articulation, et leurs moyens d'union.
- Connaître les différents axes et mouvements de l'articulation.

### **I. INTRODUCTION**

L'articulation coxo-fémorale est une articulation proximale du membre pelvien qui unit l'os coxal au fémur. C'est une diarthrose de type sphéroïde (énarthrose).

### **II. ANATOMIE DESCRIPTIVE**

#### **1) SURFACES ARTICULAIRES**

**1-La tête fémorale** : 2/3 d'une sphère de 20 à 25 mm de rayon, située à la partie supéro-médiale de l'extrémité proximale du fémur. Elle est orientée en haut, en avant et en dedans.

**2- L'acétabulum** : situé à la partie moyenne de la face latérale de l'os coxal, limité dans son pourtour par le limbus. Il est orienté en bas, en dehors et en avant. Il présente deux parties :

\*Périphérique : la surface semi lunaire, articulaire encroutée de cartilage.

\*Centrale : la fosse acétabulaire, non articulaire.

**3- Le labrum acétabulaire ou bourrelet cotyloïdien** : C'est un fibro-cartilage annulaire, qui s'insère sur le limbus avec une face axiale encroutée de cartilage hyalin. Il augmente la surface et la profondeur de l'acétabulum.

NB/Le labrum acétabulaire passe en pont au dessus de l'incisure ischio-pubienne formant: le ligament transverse de l'acétabulum.

#### **2) MOYENS D'UNIONS**

##### **A- Capsule :**

Manchon fibreux cylindrique qui s'insère sur, -le limbus, la face périphérique du labrum, le long de la ligne intertrochantérique du fémur en avant, et à la partie moyenne de la face dorsale du col fémoral.

NB/Elle présente une zone renforcée par des fibres circulaires, c'est la zone orbiculaire, et des freins capsulaires véritables replis inférieurs.

**B- Ligaments passifs****1. Le ligament ilio-fémoral ou ligament de Bertin :**

De forme triangulaire, composé de deux faisceaux s'élargissant en éventail et passant en avant de la tête fémorale.

**\*Faisceau supérieur :** Il s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure; de trajet horizontal, il se termine sur le tubercule supérieur de la ligne intertrochantérique.

**\*Faisceau inférieur :** Il s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure; de trajet oblique, il se termine sur le tubercule inférieur de la ligne intertrochantérique.

**2. Le ligament pubo-fémoral**

Il prend naissance sur l'éminence ilio-pécinée du pubis, de trajet oblique en bas et en dehors, pour se terminer à la partie toute inférieure de la ligne intertrochantérique.

**3. Le ligament ischio-fémoral**

Il est postérieur, il naît de la tubérosité ischiatique, pour se terminer sur le grand trochanter et sur la zone orbiculaire de la capsule.

**4. Le ligament de la tête fémorale ou ligament rond**

Il est intra-capsulaire et extra-synoviale.

Il prend origine sur la fovea capitis de la tête fémorale et se termine par trois faisceaux antérieur, et postérieur sur les cornes antérieure, postérieure de la surface semi lunaire et le faisceau moyen sur le ligament transverse de l'acetabulum).

Il est Centré par une artère qui irrigue la tête fémorale

**C- Ligaments actifs**

Le muscle quadriceps et ilio-psoas en avant.

Les muscles glutéaux en arrière et en dehors.

Les muscles adducteurs et pélo-trochantériens en dedans.

**3) La synoviale :**

La membrane synoviale tapisse la face profonde de la capsule. Elle secrète le liquide synovial ou synovie qui lubrifie et nourrit le cartilage articulaire.

NB/ Le ligament de la tête fémorale est par conséquent dans la position extra-synoviale et extra-articulaire, bien qu'il soit dans une situation intra-articulaire

**III. ANATOMIE FONCTIONNELLE**

Articulation très mobile, avec 3 degrés de liberté:

— Mouvement de FLEXION/EXTENSION : axe presque horizontale dans un plansagittal

—Mouvements d'ABDUCTION ET ADDUCTION :axe sagittal

—Mouvement de ROTATIONS : dans un plan transversal ,selon un axe vertical

—Mouvement de CIRCUMDUCTION : elle associe l'ensemble des mouvements

**Références :**

1. Rouviere H. Anatomie Humaine Descriptive , Topographique et Fonctionnelle. Tome 3. Membres. ed. masson 2002.

3) Hmoudi SS. Le cours d'anatomie. fasc. 2 appareil locomoteur.. membre inférieur. ISBN 2008



